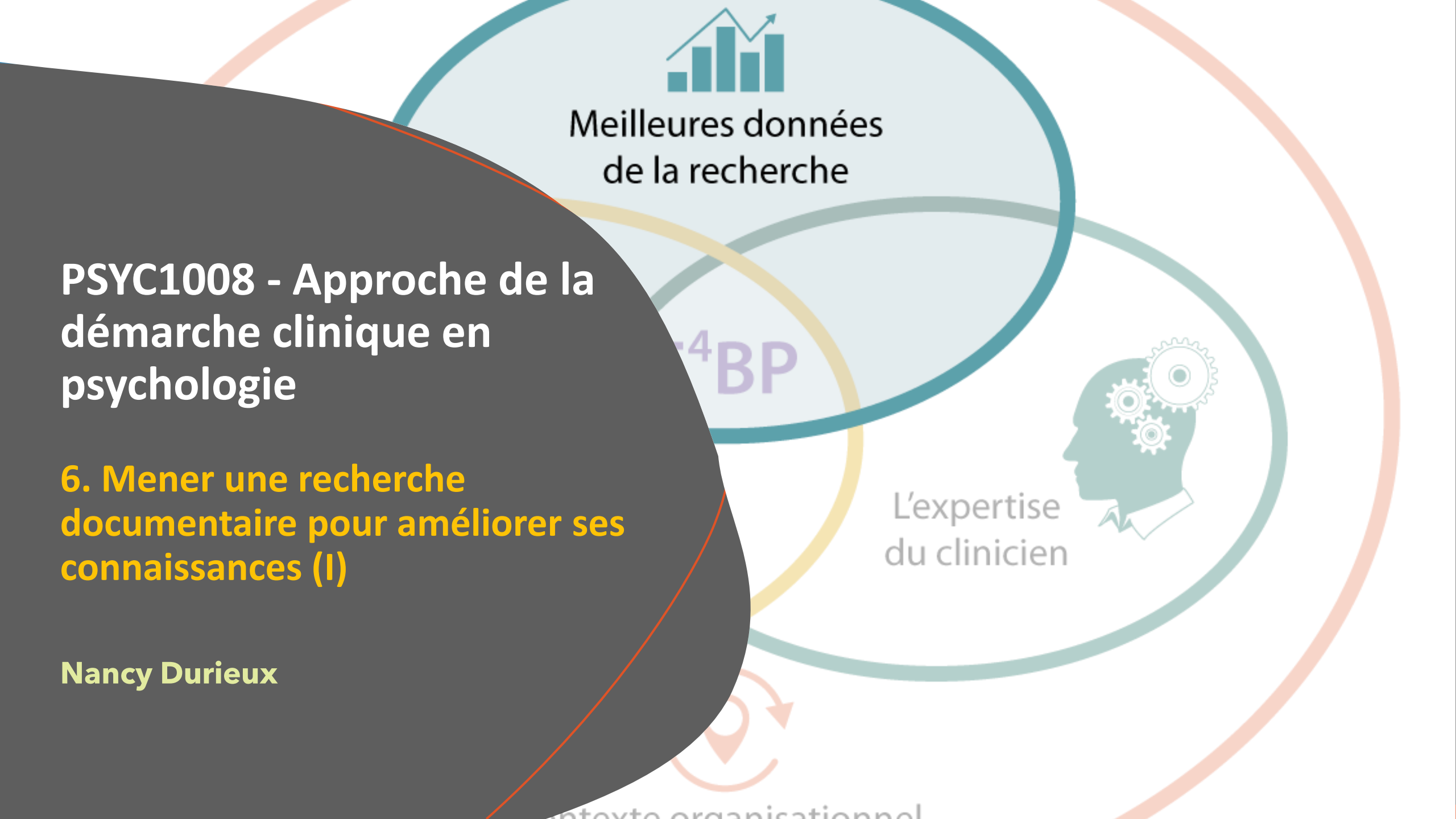
PSYC1008 - Approche de la démarche clinique en psychologie

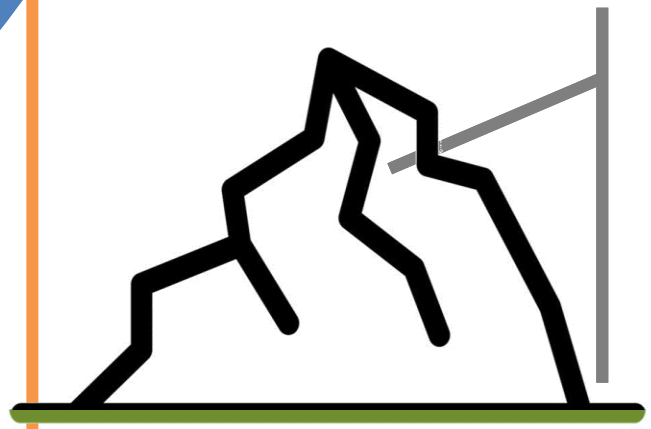
6. Mener une recherche documentaire pour améliorer ses connaissances (I)

Nancy Durieux



Démarche clinique en psychologie

Approche Centrée sur la Personne (ACP)



Ce que le psychologue (l'étudiant) fait

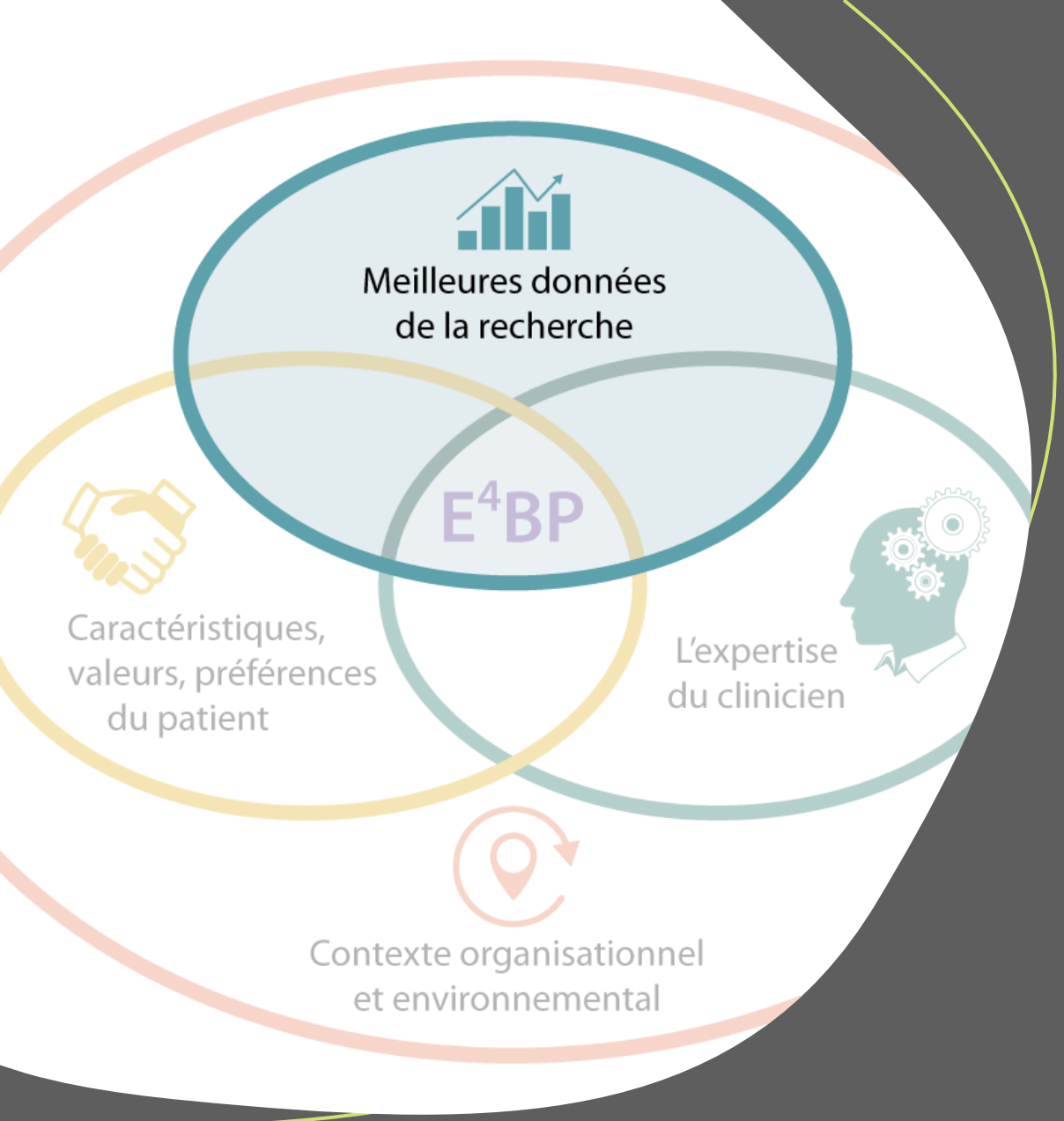


Quels processus de pensée et de prise de décision (= raisonnement clinique) amènent le psychologue (l'étudiant) à agir ainsi ?

Quelles informations alimentent le raisonnement clinique du psychologue (de l'étudiant) ?



6 7



Plan de la séance

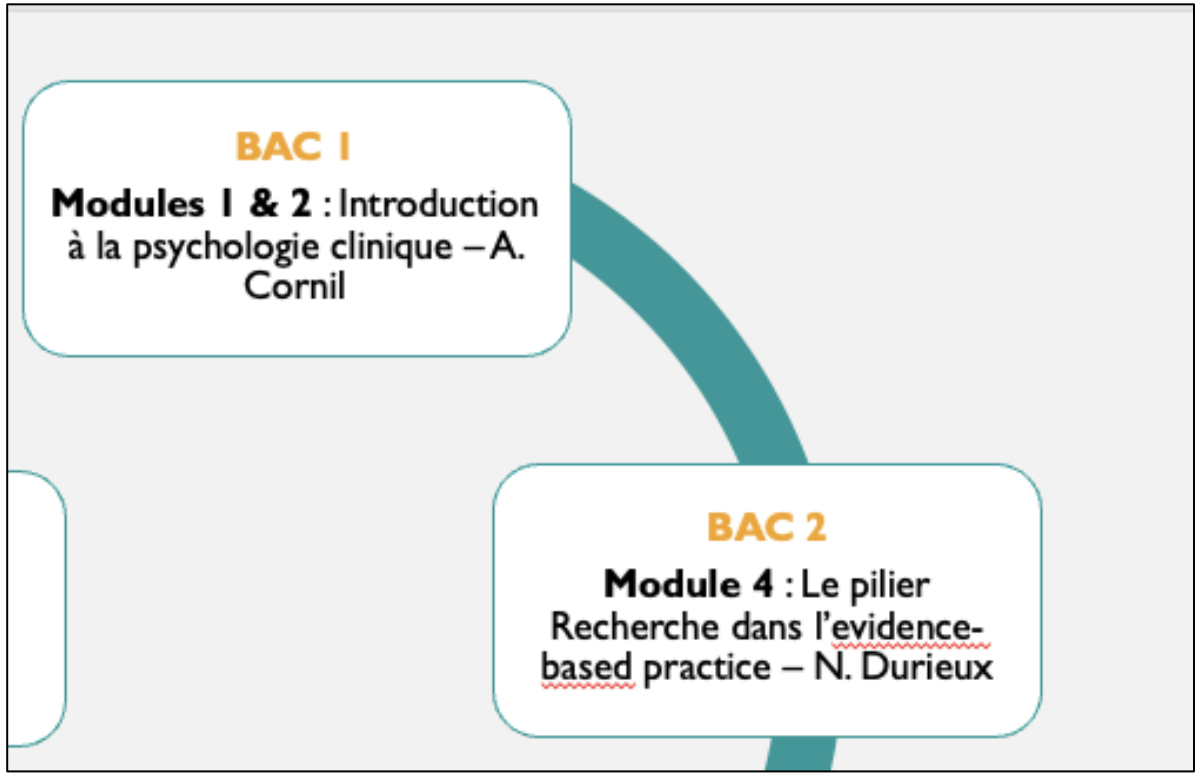
EBP en psychologie

EBP – pilier recherche (rappel)

Mise en pratique – Vignette

Evidence-based practice

De quoi vous rappelez-vous ?



PRACTICE DIRECTORATE

About Us

Leadership and Governance

Programs and Services

Professional Practice Guidelines

Practitioner Resources

Colleague Assistance and Self-care

Evidence-Based Practice in Psychology

Training Grid — Outlining Best Practices for Recovery

Subscribe to the Practice List

CONTACT APA PRACTICE DIRECTORATE

Home > Practice Directorate > Practitioner Resources >

Evidence-Based Practice in Psychology

Evidence-based practice is the integration of the best available research with clinical expertise in the context of patient characteristics, culture and preferences.

The APA Council of Representatives adopted a policy statement on Evidence-Based Practice in Psychology at their August 2005 meeting. Additionally, Council received the report written by the task force. Both the policy statement and report were written by a diverse group of members, went through extensive review and public comment before being present to Council.

- APA Policy Statement on Evidence-Based Practice
- APA Report on Evidence-Based Practice (PDF, 112KB)
- Report of the 2005 Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (PDF, 242KB)

Additional Resources

- Disseminating Evidence-Based Practice for Children and Adolescents: A Systems Approach to Enhancing Care (PDF, 3.1MB)
- Disseminating Evidence-Based Practice for Children and Adolescents: A Systems Approach to Enhancing Care — Executive Summary (PDF, 789KB)

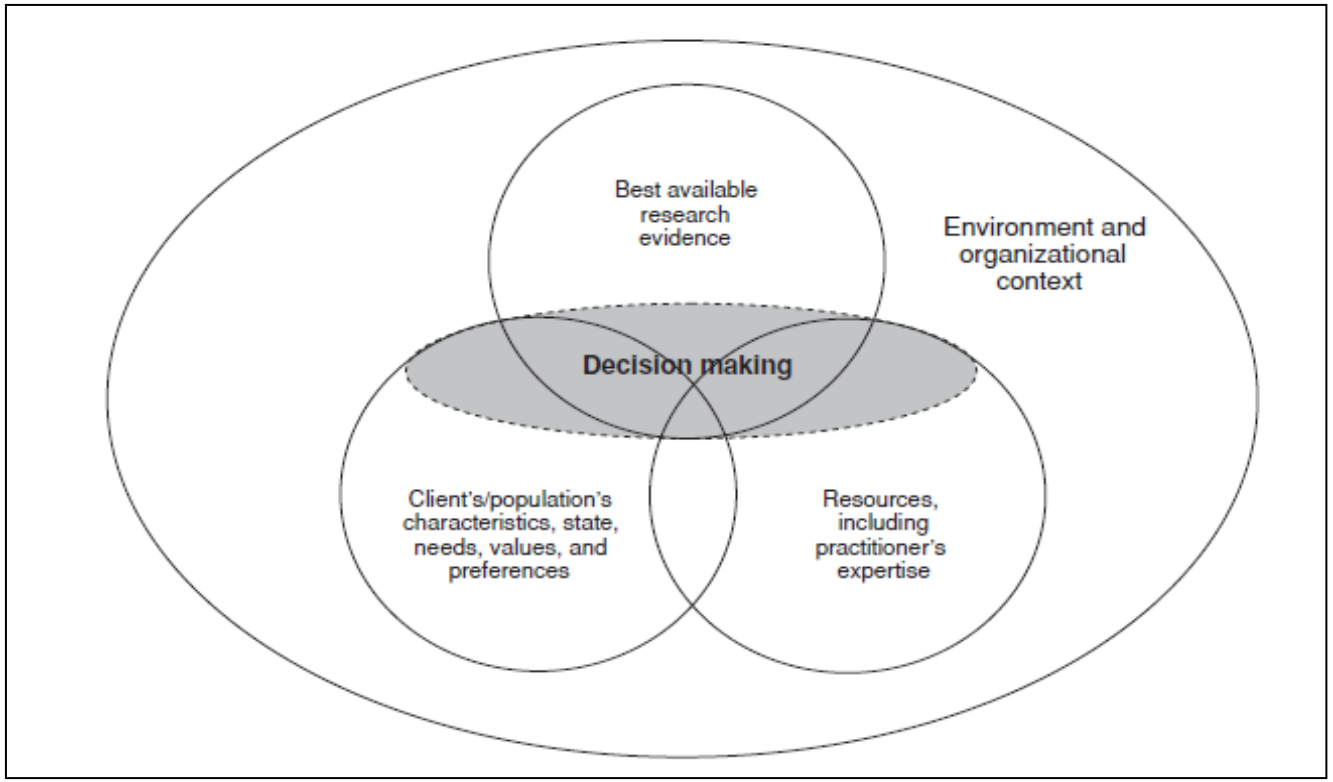


Tiré de https://www.apa.org/practice/resources/evidence (consulté le 01/10/2023)

▸ Milbank Q. 2009 Jun 4;87(2):368–390. doi: 10.1111/j.1468-0009.2009.00561.x

Toward a Transdisciplinary Model of Evidence-Based Practice

Jason M Satterfield [1], Bonnie Spring [1], Ross C Brownson [1], Edward J Mullen [1], Robin P Newhouse [1], Barbara B Walker [1], Evelyn P Whitlock [1]



Decision making = cognitive action that turns evidence into contextualized evidence-based practices

Pratique collaborative des soins de santé

->Implications

- pratique clinique
- politiques de soins de santé
- recherche scientifique
- formation des professionnels de la santé

ELSEVIER

Pratiques Psychologiques

Volume 30, Issue 4, November 2024, Pages 205-221



Article hors thème

L'*evidence-based practice* en psychologie : une approche tripartite souvent mal comprise

Sacha Delphine Blause, Nancy Durieux, Ezio Tirelli, Sylvie Willems

Enquêté lancée en 2017

Questions format QCM

110 psychologues belges francophones

L'objectif de cette étude était d'investiguer les connaissances des psychologues concernant l'EBP mais également l'usage de cette démarche dans leur pratique quotidienne.

Les résultats obtenus ont montré qu'une méconnaissance de l'EBP est présente chez une partie des psychologues francophones inclus dans cette étude. En effet, environ un tiers de l'échantillon n'avait jamais entendu parler de cette pratique, un tiers était familier avec le terme sans être capable de définir l'approche, la confondant avec l'utilisation de traitements empiriquement fondés ne prenant pas assez en compte les facteurs relationnels et le patient dans son individualité et sa complexité. Nous pouvons toutefois considérer dans un premier temps les résultats encourageants de cette étude. Après avoir reçu un bref descriptif de l'approche, 62 % de l'échantillon l'ont estimée incontournable ou intéressante et la moitié de l'échantillon a estimé leur pratique déjà conforme à l'EBP. Le manque de connaissances et savoir-faire nécessaire a été souligné par plus de la moitié, tout comme le désir d'en apprendre davantage ou de se former. Le manque de connaissances et de compétences (Haider & Dunstan, 2019 ; Jurišević et al., 2019 ; Pagoto et al., 2007) sont des barrières déjà bien connues. Ces résultats rejoignent les données d'autres enquêtes. Par exemple, dans une étude portant sur 59 cliniciens américains,



Cebam

Formation Validation Evaluation Cochrane Belgium JBI Belgium Guides-patients ebpracticenet Vers le CDLH

Mesure de la culture EBP

Mesure de la culture EBP chez les prestataires de soins de première ligne

Pour évaluer la culture EBP chez différentes professions de la première ligne, nous avons élaboré une enquête. Elle s'adresse aux médecins généralistes, infirmiers, ergothérapeutes, dentistes, diététiciens, pharmaciens, kinésithérapeutes, logopèdes, sage-femmes, podologues et psychologues. Ce sont les professions représentées dans le réseau EBP.

Rapports

- Rapport général mesure de la culture EBP chez les prestataires de soins 2022

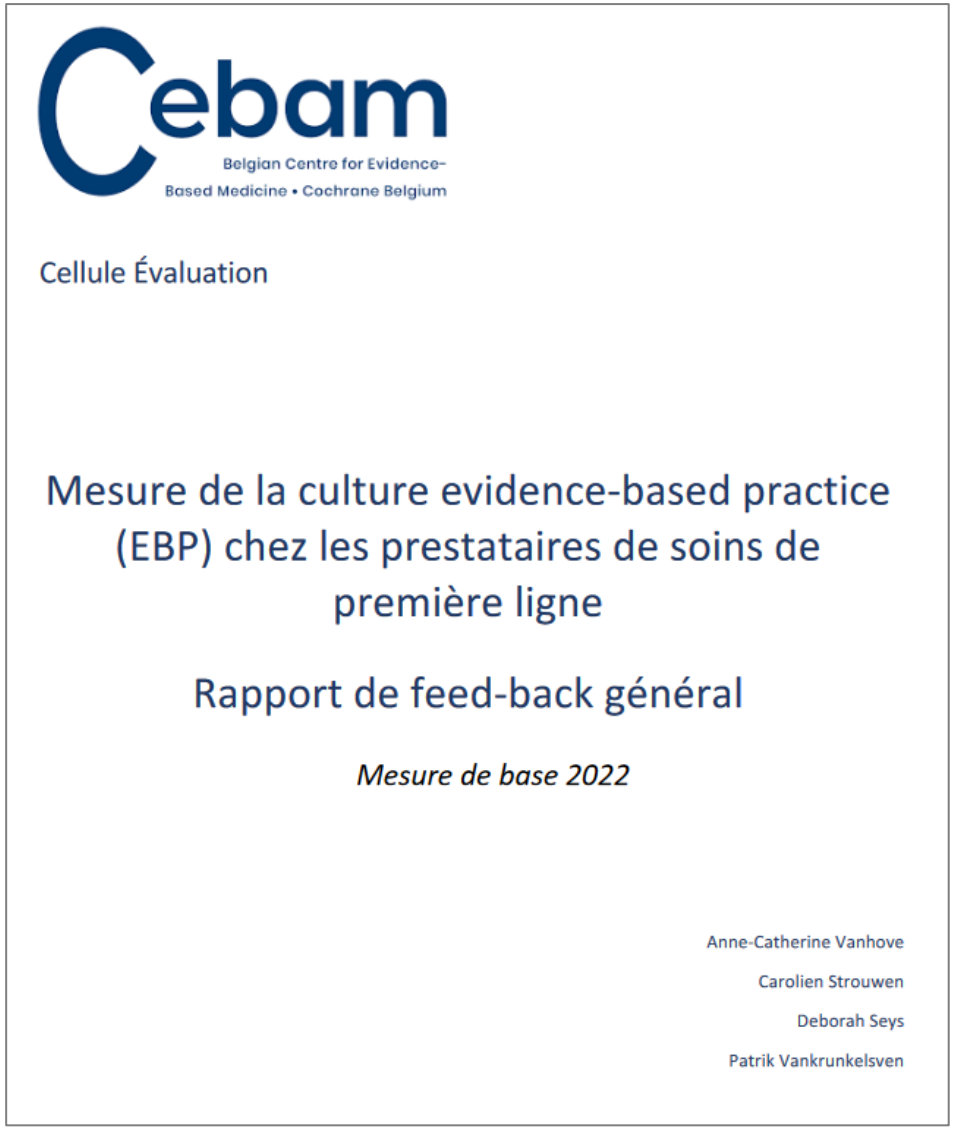
Mesure de la culture EBP chez les citoyens

Quelle est la perception des citoyens vis-à-vis de l'EBP ? Pour le savoir, nous avons développé une enquête spécifique en collaboration avec Gezondheid & Wetenschap (une site néerlandophone avec de l'information en santé fiable et en langage clair). Cette enquête sera administré tous les 3 ans.

Rapports

- Rapport mesure de la culture EBP chez les citoyens 2023

https://www.cebam.be/fr/evaluation/cultuurmeting


Cebam
Belgian Centre for Evidence-Based Medicine • Cochrane Belgium

Cellule Évaluation

Mesure de la culture evidence-based practice (EBP) chez les prestataires de soins de première ligne

Rapport de feed-back général

Mesure de base 2022

Anne-Catherine Vanhove
Carolien Strouwen
Deborah Seys
Patrik Vankrunkelsven

Enquête en ligne réalisée du 3 mai au 30 juin 2022

Prestataires de soins de 1re ligne
(11 groupes professionnels)

E-mail via le service eHealthBox
+ invitation en demandant aux associations professionnelles de diffuser l'enquête

1. Groupe professionnel

La majorité des répondants sont des médecins généralistes (38,5 %, n : 874), suivis des kinésithérapeutes (20,3 %, n : 460) et des dentistes (19,5 %, n : 443). Les podologues et les sages-femmes sont les groupes les moins représentés dans cette étude (0,4 %, n : 9) (Tableau 1).

TABLEAU 1 DETAILS PAR GROUPE PROFESSIONNEL

	n(%) NL	n(%) FR	n(%) Total
Médecin généraliste	551 (40,0 %)	323 (36,2 %)	874 (38,5 %)
Kinésithérapeute	221 (16,1 %)	239 (26,8 %)	460 (20,3 %)
Dentiste	313 (22,7 %)	130 (14,6 %)	443 (19,5 %)
Logopède	61 (4,4 %)	83 (9,3 %)	144 (6,3 %)
Infirmier·ère	115 (8,4 %)	21 (2,4 %)	136 (6,0 %)
Pharmacien·ne	22 (1,6 %)	37 (4,1 %)	59 (2,6 %)
Ergothérapeute	33 (2,4 %)	22 (2,5 %)	55 (2,4 %)
Psychologue clinicien·ne	26 (1,9 %)	23 (2,6 %)	49 (2,2 %)
Diététicien·ne	20 (1,5 %)	11 (1,2 %)	31 (1,4 %)
Podologue	8 (0,6 %)	1 (0,1 %)	9 (0,4 %)
Sage-femme	6 (0,4 %)	3 (0,3 %)	9 (0,4 %)

La répartition du nombre de répondants dans les différents groupes professionnels est présentée dans

Prestataires de soins de 1re ligne

Remarque



Contact Presse Agenda Glossaire Liens utiles Travailler à l'INAMI

INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité

Rechercher

Accueil Thèmes Professionnels Nomenclature Programmes web Publications Statistiques L'INAMI FAQ LIKIV

Accueil › Professionnels › Professionnels de la santé › Psychologues cliniciens › **Dispenser des soins psychologiques de première ligne via un réseau de santé mentale**

- Aides-soignants
- Audiciens
- Bandagistes
- Dentistes
- Diététiciens
- Ergothérapeutes
- Fournisseurs d'implants
- Hygiéniste bucco-dentaire
- Infirmiers
- Kinésithérapeutes
- Logopèdes
- Médecins
- Opticiens
- Orthopédagogues cliniciens
- Orthopédistes
- Orthoptistes
- Pharmaciens
- Pharmaciens biologistes

Dispenser des soins psychologiques de première ligne via un réseau de santé mentale

À partir de 1er avril 2024, une nouvelle convention entre en vigueur. Elle renforce et étend progressivement l'offre de soins psychologiques de première ligne dans l'ensemble du pays de manière coordonnée.
Voici comment fonctionne cette offre de soins psychologiques, et comment vous pouvez vous y engager.

Sur cette page :

- La convention de soins psychologique de première ligne avec les réseaux de santé mentale
- Une offre de soins adaptée aux besoins de la population
- Les soins psychologiques de première ligne
- Quels sont les prestataires de soins qui peuvent dispenser ces soins?
- Combien paie le patient ?
- Quelle rémunération pour le professionnel ?
- Envie de vous engager en tant que prestataire de soins ?

Quels sont les prestataires de soins qui peuvent dispenser ces soins?

Dans ce système, les traitements ou séances sont effectués par des psychologues/orthopédagogues cliniciens faisant partie d'un réseau de santé mentale ayant signé une convention avec l'INAMI. Cela signifie qu'ils répondent aux critères de qualité pour exercer au mieux leur profession dans ce système de réseau. Ils font partie d'un réseau multidisciplinaire et participent aux activités organisées par le réseau telles que la formation, la supervision, la concertation, etc.

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/psychologues-cliniciens/dispenser-des-soins-psychologiques-de-premiere-ligne-via-un-reseau-de-sante-mentale

Résumé

Questions générales relatives à l'EBP

- 90,1 % des répondants ont déjà entendu parler de l'EBP
- 92,6 % des répondants savent que l'EBP repose sur des observations scientifiques
- 18,9 % des répondants identifient cependant correctement les trois piliers de l'EBP
- 53,3 % des répondants estiment qu'il y a suffisamment d'informations disponibles sur l'EBP, pour tous les sujets ou pour la plupart
- 40 % des répondants connaissent le réseau EBP
- 33,5 % des répondants connaissent et utilisent des outils/applications pour évaluer leurs propres actions

Formation

- 42,2 % des répondants ont déjà suivi une formation formelle dans les quatre domaines de l'EBP
- 39,6 % des répondants trouvent très important ou extrêmement important de suivre une formation formelle dans les quatre domaines de l'EBP

Connaissance et utilisation de l'EBP

- 83,3 % des répondants effectuent des recherches via l'un des canaux proposés au moins une fois par mois
- 63,2 % des répondants cherchent des réponses par des moteurs de recherche généraux au moins une fois par mois
- 27,1 % des répondants visitent le site Internet d'ebpracticenet au moins une fois par mois
- 18,8 % des répondants visitent le site Internet de la CDLH au moins une fois par mois
- 10,0 % des répondants visitent le site Internet de Minerva au moins une fois par mois
- 54,1 % des répondants cherchent des réponses grâce aux informations qu'ils ont apprises dans le cadre de leur formation de professionnel de la santé au moins une fois par mois
- 19,3 % des répondants déclarent chercher des informations via des bases de données internationales d'informations dites « point-of-care » ou de guides de pratique clinique au moins une fois par mois, tandis que 50,3 % des répondants ne connaissent pas ces sources EBP

Croyances et attitudes

- 73,5 % des répondants sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'application de l'EBP est indispensable dans leur pratique
- 17,3 % des répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle l'application de l'EBP dans leur travail quotidien impose des exigences déraisonnables
- 15,2 % des répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle les préférences du patient les empêchent d'appliquer l'EBP

Auto-efficacité

Les participants ont :

- le plus confiance dans leur niveau de compétence lorsqu'il s'agit de comprendre les besoins et les préférences du patient
- le moins confiance dans leur niveau de compétence lorsqu'il s'agit d'évaluer de manière critique la fiabilité et la pertinence des informations trouvées

Mise en œuvre

- 73,9 % des répondants collectent des informations EPB dans le cadre de leur pratique quotidienne au moins une fois par mois par l'un des canaux proposés
- 47,7 % des répondants collectent des informations EBP sur un problème clinique au moins une fois par mois
- 50,5 % des répondants ne partagent jamais d'informations EBP avec des collègues au moyen d'un rapport ou d'une présentation
- 68,0 % des répondants se disent prêts à ajuster leurs actions sur la base du feed-back reçu

Barrières et facilitateurs

- 90,5 % des répondants s'intéressent à l'EBP
- 80,6 % des répondants ont besoin d'informations EBP adaptées au contexte belge
- 43,6 % des répondants pensent que les actions des deuxième et troisième lignes entrent souvent en conflit avec l'EBP
- 29,9 % des répondants pensent que le niveau de littératie du patient les empêche d'appliquer l'EBP

Et à ce jour ?

- Retours informels du terrain
- Nouvelle enquête en cours du CEBAM
- Et dans les autres pays ?

Les patients ont souvent encore des questions après une consultation avec leur professionnel de la santé.



Mesure de la culture evidence-based practice (EBP) au sein de la population belge

Rapport

Mesure de base 2023

Cebam
Belgian Centre for Evidence-Based Medicine

avec le soutien (financier) de

Empowered by the evikey Network

RIZIV

Questionnaire en ligne

distribué par iVOX

à 1 000 citoyens belges issus de leur panel de recherche

entre le 20 et le 30 octobre 2023

Cebam

Quelques résultats marquants

*Les Belges interrogés préfèrent obtenir des **informations sur leur santé** auprès de leur **médecin généraliste**, mais le plus souvent via **Internet**.*

4/5 *s'intéressent aux informations sur la santé*

1/3 *recherche activement des informations sur la santé*

3/5 *se sentent souvent ou (presque) toujours impliqués dans leurs soins de santé*



3/4 *se disent bien informés sur leur santé après avoir consulté leur professionnel de la santé*

3/4 *se sentent à l'aise pour faire part de leurs inquiétudes et de leurs plaintes à leur professionnel de la santé*

En moyenne, les Belges interrogés font davantage confiance aux sites web consacrés à la santé qu'aux médias classiques (presse écrite, télévision, radio).

1/3

- *se sent parfois dépassé par la quantité d'informations lors d'une visite chez son professionnel de la santé*
- *indique que la recherche d'informations sur la santé l'a souvent ou presque toujours conduit à consulter un médecin généraliste ;*
- *indique que la recherche d'informations n'a jamais ou seulement une fois conduit à consulter un médecin généraliste*

9/10 *veulent discuter des différentes options de traitement avec leur professionnel de la santé*

4/5 *souhaitent travailler en équipe avec leur professionnel de la santé pour choisir le meilleur traitement*

1/2 *indique qu'il lui est plutôt difficile, voire très difficile, d'évaluer la fiabilité des risques pour la santé apparaissant sur les réseaux sociaux*

7/10 *indiquent qu'ils ont un niveau limité de littératie en matière de santé*

Deux séances sur l'EBP dans le PSYC1008



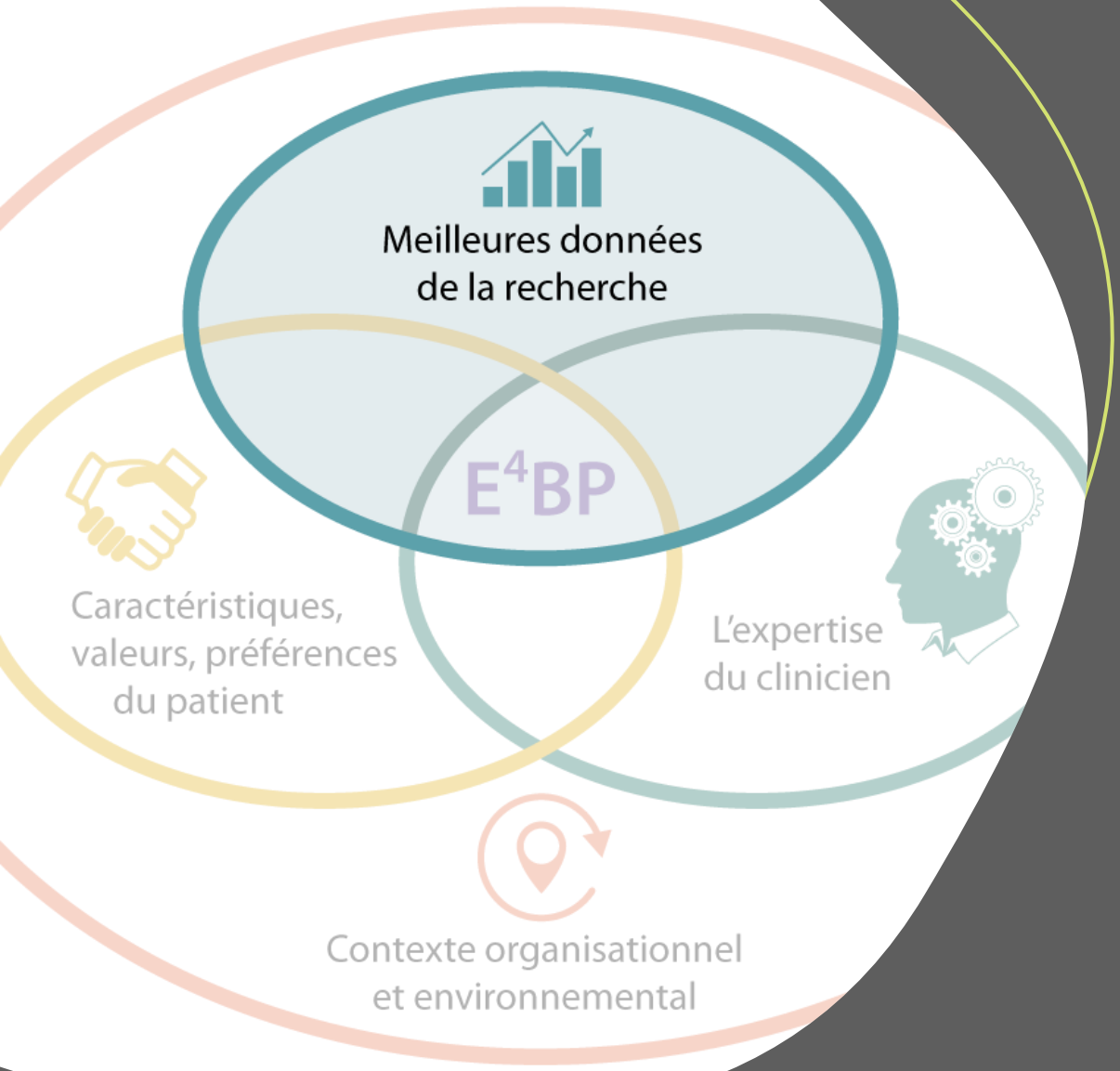
sur les cliniciens – « premier entretien »

Objectif ?

Vous initier à l'intégration des principes de l'EBP dans le raisonnement clinique et la prise de décision dans des situations complexes

Note : compétences qui continueront à se construire et se consolider au fil de votre formation et de vos expériences professionnelles

Image tirée de https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/05/01/48/dart-board-25780_960_720.png



Plan de la séance

EBP en psychologie

EBP – pilier recherche (rappel)

Mise en pratique – Vignette

Rappel : pilier recherche

- Types de questions ?
- Manières de concevoir des recherches en psychologie ?
- Types de d'études / de documents ?
- Types de sources (outils de recherche d'information) ?
- Manières d'évaluer (des documents rapportant) des études qui ont été menées ?

Questions

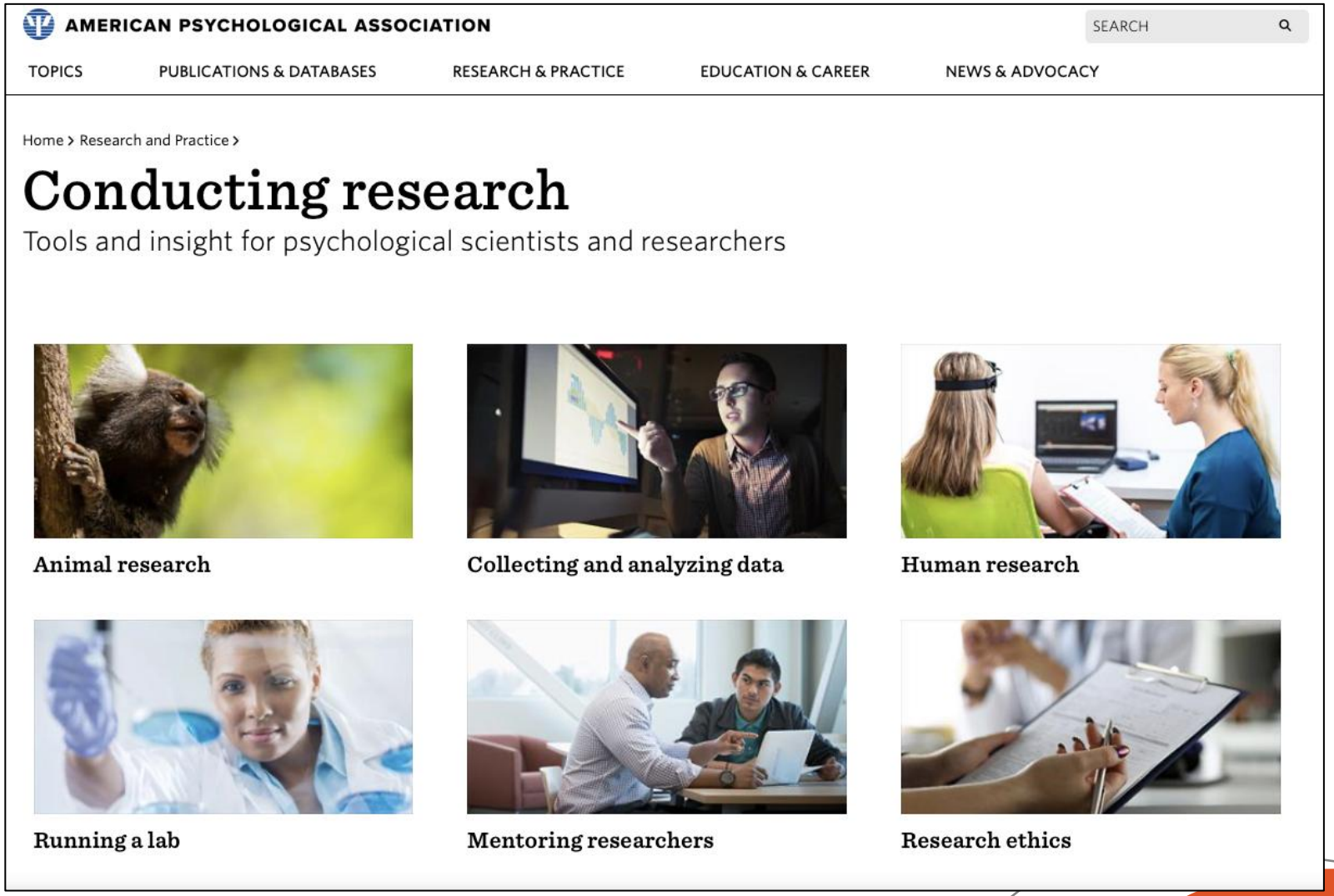
- *Background*

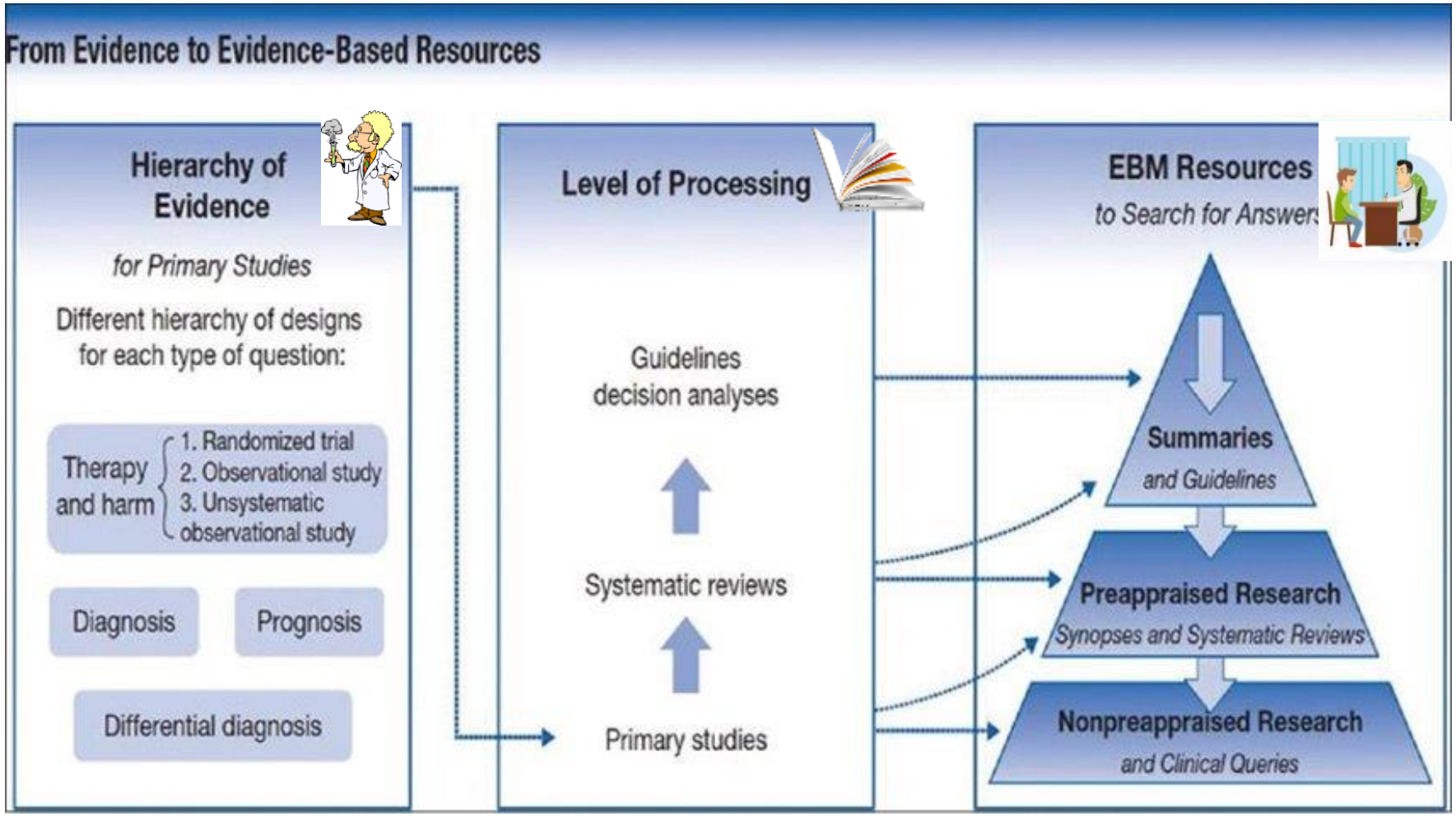
  Ex : Qu'est-ce que la dépression ?

- *Foreground*

  Ex : Les TCC (quelles que soient les modalités de prise en charge) sont-elles plus efficaces (à court et à long terme) que les autres prises en charge considérées (autres psychothérapies, pharmacothérapies ou combinaison des deux) pour le traitement de la dépression (intensité des symptômes, récidives, rémission), quels que soient l'âge et le contexte (ambulatoire ou hospitalier) ?

Concevoir des recherches en psychologie





Rem. : study ≠ report

Tiré de Agoritsas et al. (2015). Finding current best evidence. In G. Guyatt, D. Rennie, M. O. Meade, & D. J. Cook (Eds.), *Users' guide to the medical literature: essentials of evidence-based clinical practice* (3rd ed., pp. 43-84). McGraw-Hill Education.

Documents

- Articles scientifiques
- Livres (chapitres de)
- Actes de congrès
- Thèses de doctorat
- …

Notes :

*rapports publiés, non publiés, littérature grise

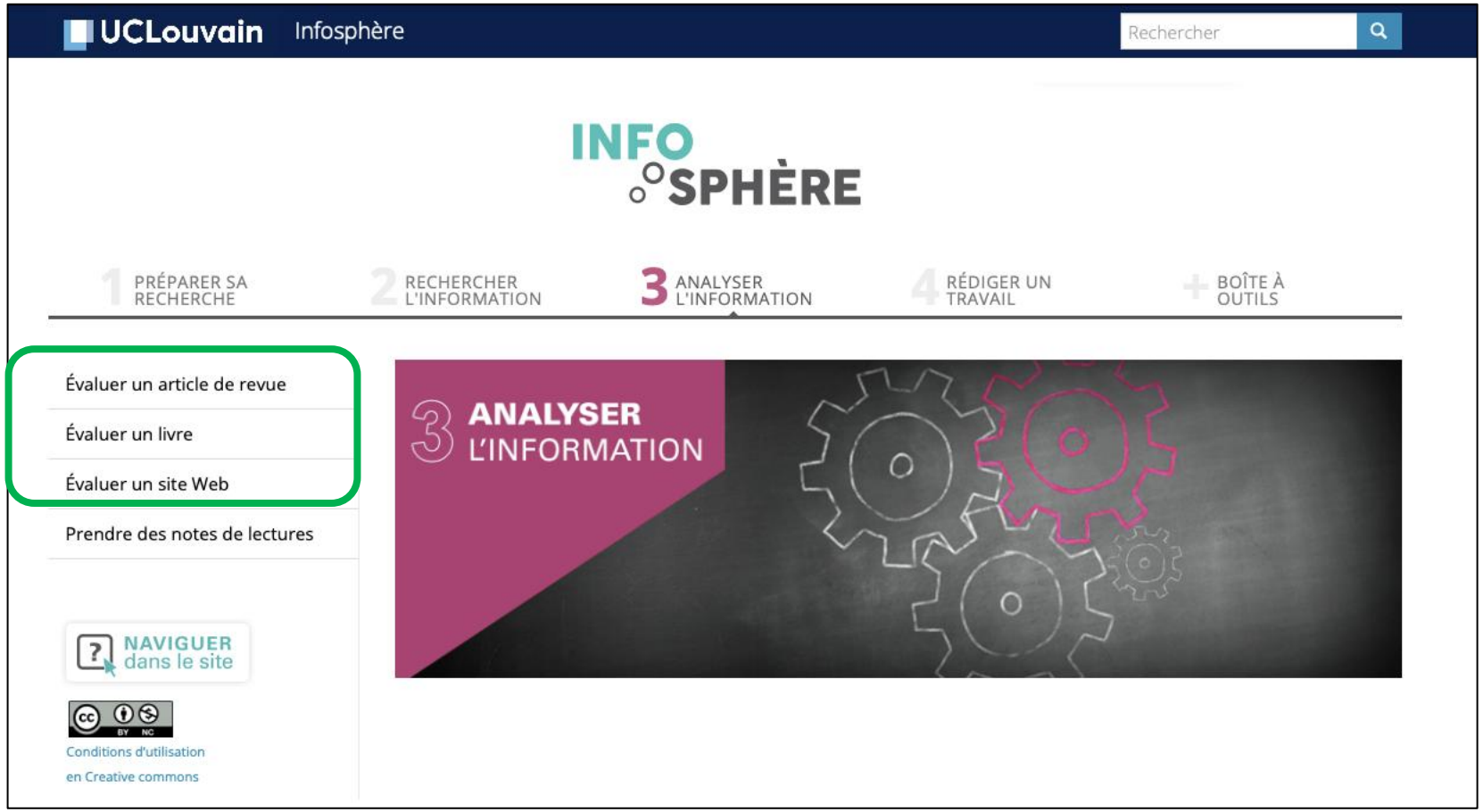
**Study ≠ report*

Sources (« outils »)

- Bases de données bibliographiques
- Moteurs de recherche
- Catalogues de bibliothèques
- Sites web
- …

Evaluation de la pertinence et de la qualité du contenu

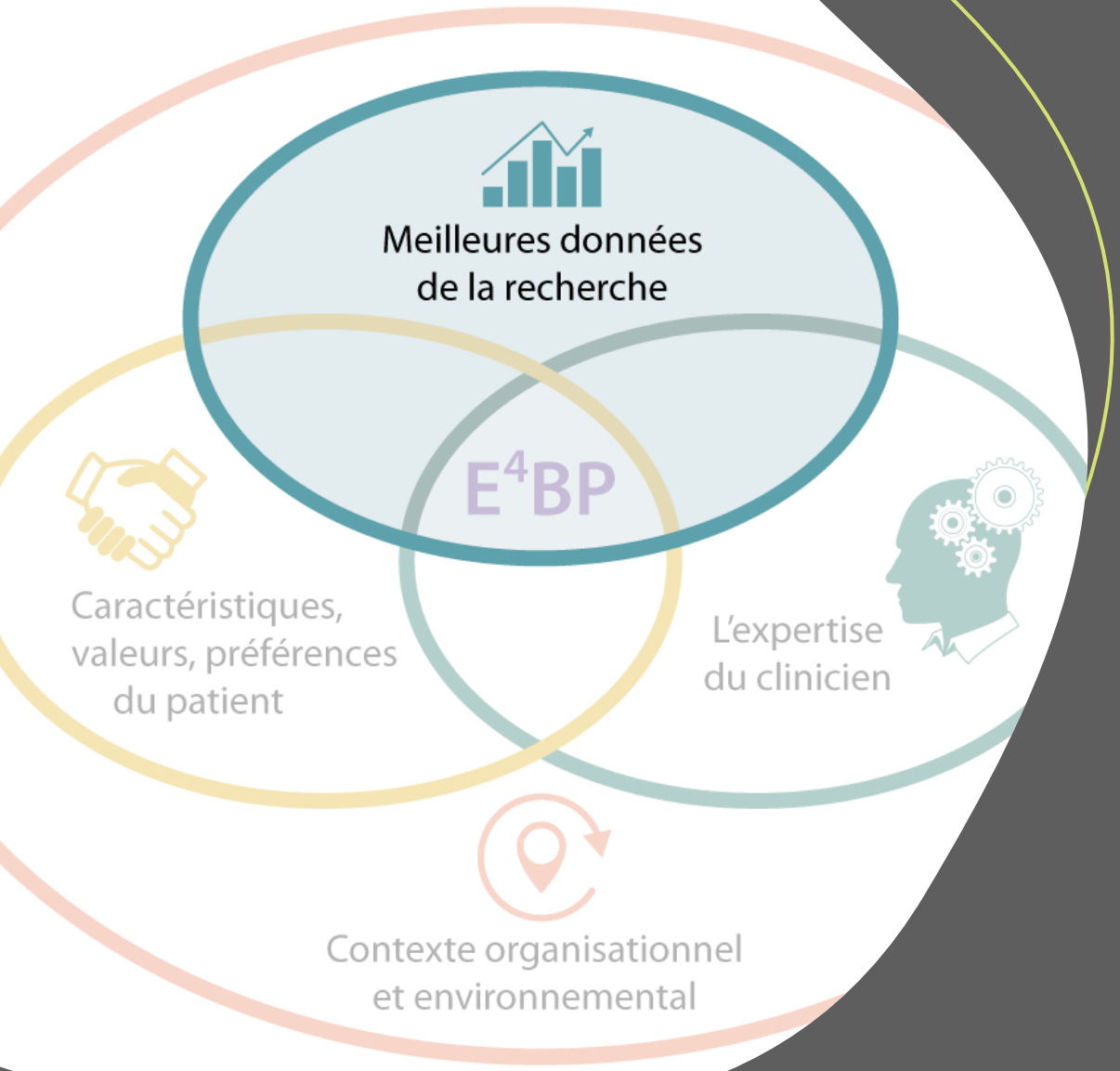
- PERTINENCE DU CONTENU
- FIABILITÉ DES SOURCES
- RÉPUTATION DE L'AUTEUR
- OBJECTIVITÉ DE L'INFORMATION
- EXACTITUDE DE L'INFORMATION
- ACTUALITÉ DE L'INFORMATION



https://legacy.bib.uclouvain.be/infosphere/analyser-linformation

Lecture approfondie

- Exemples de grilles d'évaluation
    - *Critical appraisal tools* du JBI
        - https://jbi.global/critical-appraisal-tools
    - CASP checklists
        - https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/systematic-reviews-meta-analysis-rcts/



Plan de la séance

EBP en psychologie

EBP – pilier recherche (rappel)

Mise en pratique – Vignette

Dans la pratique clinique

Les cliniciens peuvent se poser des questions

avant et/ou pendant et/ou après un entretien

-> Se poser des questions et explorer la littérature scientifique pour y répondre = une piste pour enrichir vos connaissances et préparer vos séances



Vignette 1

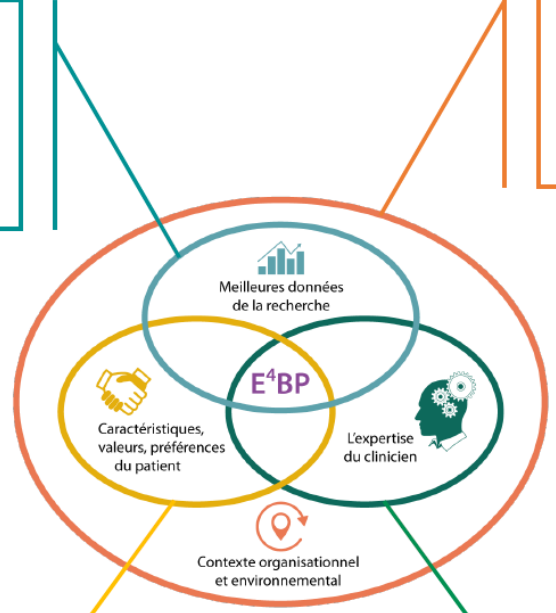
Nadine téléphone pour prendre rendez-vous. Elle est pensionnée depuis 5 ans. Elle oublie de plus en plus depuis quelques mois. Elle voudrait un bilan neuropsychologique. Elle viendra seule.

Que sait-on ?



Vignette 1

Soins de santé > Honoraires



Femme
Une soixantaine d'années
Une certaine autonomie
Se plaint de troubles de la mémoire depuis qqs mois
Demande : bilan neuropsy

Neuropsychologue à la CPLU + CRA

Représentation d'une clinicienne



Vignette 1

Culture > R° personne âgée ?



Suspicion de démence chez une femme âgée

Cours du bachelier
XP entourage

Représentation pouvant être observée chez un novice > pas de distinction entre les faits et les hypothèses



Vignette 1

Nadine téléphone pour prendre rendez-vous. Elle est pensionnée depuis 5 ans. Elle oublie de plus en plus depuis quelques mois. Elle voudrait un bilan neuropsychologique. Elle viendra seule.

Quelles sont les hypothèses et les questions qui vous viennent en tête ?

Exercice

- Quelles sont les questions que vous vous posez ?

  Questions par rapport à la patiente et questions de type *background* par rapport aux troubles de la mémoire ou autres

  Et quelles hypothèses formulez-vous ?

  Sources à consulter ? Stratégies de recherche ?
  Types de documents ?
  Pertinence et qualité du contenu des documents ?
  Informations trouvées ?

Note : les questions à poser peuvent aussi être identifiées au fil des lectures

Exemples de sources à consulter – en binôme

1. UpToDate
2. Ebpracticenet
3. Catalogue de l'ULiège Library
4. Minerva
5. PubMed
6. Google (Scholar)
7. InfoSanté

Rappel :
sources vues lors du cours PSYC0085

Remarque

Définition : trouble de la mémoire / *memory disorder*



APA dictionary

Handbooks en psychologie

Larousse

A faire pour cette séance

Consulter

1. UpToDate
2. Minerva (prochaine séance)
3. InfoSanté (prochaine séance)

➔ Stratégies de recherche ?
Types de documents ?
Pertinence et qualité du contenu des documents ?
Informations trouvées ?